	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	CÓDIGO:
	FORMATO UNIDAD DE ANALISIS DE CASOS CLÍNICOS	SP-S-F-009
	PROCESO: GESTIÓN SEGURA	VERSIÓN:
	SUBPROCESO: SEGURIDAD DEL PACIENTE	V02-2026

1. DATOS DEMOGRAFICOS			
Nombres	TATIANA LÓPEZ RODRIGUEZ	**Identificación**	1019119538
Fecha y Lugar de Análisis	22/04/2026	**Edad**	29
Sexo	FEMENINO	**Ocupación**	
Fecha de evento	17/04/2026	**Evento**	ANALISIS DE EVENTO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
EPS	NUEVA EPS		

2. DATOS RELEVANTES	
Antecedentes	PATOLOGICOS hipotiroidismo gestacional migraña exposición topiramato en primer trimestre HOSPITALIZACION :migraña TOXOCOLOGICOS : no alergias a medicamentos QUIRURGICOS : niega FARMACOLOGICOS : levotiroxina 100 mg cada día asa 150 mg calcio FAMILIARES : familiar abuela ca ovario TRANSFUSIONALES : niega TRAUMATOLOGICOS : niega GINECOLOGICOS : CPN 4 hemoclasificación paciente o negativo RH pareja o positivo menarquia 14 ciclo 30/5 PNF acos PNF pos evento pomeroy. antecedente familiar de preeclampsia niega primipaternidad negativa previos p1: a término sin complicaciones - p2 a término sin complicaciones refiere que en el segundo embarazo no le administraron resuman a pesar de que el hijo es o positivo fup 08/08/2015 peso al nacer no recuerda EG 40 sem riesgo obstétrico actual : riesgo isoinmunización + hipotiroidismo gestacional + migraña crónica tensional + exposición topiramato en LABORATORIOS 7/10/2025: glicemia 76, rubeola ig m neg, cmv ig g positivo, rubeola ig g positivo, toxo ig m neg, toxo ig g neg, tsh 8, cmv ig m neg, treponema neg, Antígeno de superficie de hepatitis B neg, ffv neg, hb 13.5 hto 13.5 plt 288.00, urocultivo neg, chagas totales neg, agshb neg, 29/10/2025: anticuepos positivo, tsh 7.07, t4l 1.04, t3l 2.58 18/12/2025 tsh 0.69 t4 libre 1.26 toxo igm neg , Coombs indirecto neg 30/1/2026 tsh 4.56 toxo igm neg t4 libre 0.77

	ECOGRAFIA: 24/10/2025 embarazo de 13.2 semanas 07/01/2026 cervicometria normal 27/01/2026 ecografía Doppler de arterias uterinas: bajo riesgo 30/03/2026 Doppler de vasos venosos de miembros inferior derecho: no se observan signos de trombosis venosa profunda aguda en miembro inferior derecho al momento del estudio, trayectos subdérmicos epifasciales en la cara posterior del tercio medio de la pierna derecha permeables 07/04/2026 detalle: emb 35.6 semanas, bienestar fetal, crecimiento fetal en p 29%
3. descripción del evento	
resumen del caso	15/04/2026 12:15 p. m inicio de la atención Paciente de 29 años g3p2v2que ingresa el 15/04/2026 12:15 p. m inicio de la atención con embarazo de 38 semanas por ecografía de tamizaje, consulta por cuadro clínico de aproximadamente 7 horas de evolución consistente en ausencia de percepción de movimientos fetales, niega dinámica uterina, niega perdidas vaginales, asintomática para vasoespasmo, niega cefalea, niega fosfenos, niega tinnitus, niega epigastralgia, no edema, refiere adicionalmente ausencia de deposiciones hace 3 días, . en el momento clínica y Hemodinámicamente estable, alerta, afebril, hidratada, normotensa, altura uterina concordante con edad gestacional, fetocardía audible con Doppler escuchado por la paciente, se solicita monitoria fetal + perfil biofísico a definir bienestar fetal, se indica enema para administración ahora, se revalorara con reportes según evolución Se toma ecografía obstétrica transabdominal. placenta de inserción fúndica posterior, grado II de madurez en escala de I/III peso fetal aproximado de 2703 gr. p: 6.8% líquido amniótico 14.5 cm opinión: embarazo de 35 semanas 5 días +/- por biometría fetal. FPEG VS RCIU FPP: 15/05/2026 Se considera por el hallazgo ecográfico PEF 2703 gr p 6.8%, ila 14.5, embarazo de 35.5 por biometría, FPEG VS RCIU, hospitalizar para finalización del embarazo dado que no amerita expectancia, se ingresa para inducción del parto ,con dos dosis de misoprostol 25 mcg según protocolo , con posterior manejo con oxitocina a dosis baja, con parto vaginal el 17/04/2026 antropométricas peso 2715 gr talla 46 cm, pc 32 cm, pt 33 cm, PA 30 cm APGAR a los 5 minutos 10/10, sexo masculino hora de nacimiento 08+50 am Apgar 9/10 -- /10/10 SILVERMAN 0 diuresis positiva deposición negativo.

	se realiza nota pos parto de la madre según norma y protocolo institucional y se evidencia indicación de aplicación de inmunoglobulina anti d , con posterior aplicación por parte de enfermería . se evidencia aplicación de inmunoglobulina anti D al recién nacido por. Lo que se. Inicia monitorización estricta al recién nacido con valoración por pediatría, evidenciando rubicundez generalizada sin signos de dificultad respiratoria, auscultación cardio pulmonar normal, glucometría 76 , se garantizar acceso venoso permeable,manej con líquidos endovenosos y se solicitan paraclínicos para el recién nacido . El recién nacido es valorado el 17/04/2026 08+50 am por pediatría , en compañia de su madre quien manifiesta deposiciones y diuresis (+), tolerando y aceptando la vía oral (lactancia materna exclusiva) no fiebre ni otro síntoma, al examen físico con constantes vitales normales , al examen físico con hallazgo de rubicundez generalizada, sin signos de dificultad respiratoria, auscultación cardio pulmonar normal, abdomen blando, depresible no se torna irritable a la palpación, glucometría 76 mg/dl, se indica manejo con líquidos endovenosos, vigilancia estricta, se solicita función hepática, renal, tiempos de coagulación, bilirrubinas, hemograma. se decide iniciar tramite de remisión para vigilancia y manejo en uci neonatal prioritaria, por riesgo de efectos adversos a administración de inmunoglobulina: hemolisis, anemia, ictericia, entre otras, se explica claramente a la madre, quien manifiesta comprender y aceptar. el recién nacido se hospitaliza con vigilancia estricta con ligera prolongación de tiempos de coagulación ,con bilirrubinas en límite superior, presenta dificultar para la canalización por difícil acceso venoso Se intenta puncionar por 4 veces sin lograr acceso venoso , se inicia manejo con fototerapia que posteriormente se suspende por niveles de bilirrubinas en 11 no candidato a fototerapia . se remite paciente a clínica FOSCAL FLORIDABLANCA para vigilancia en nivel de mayor complejidad el 21/04/2026
4. FACTORES DE RIESGO DEL PACIENTE	
Biológicos	Antecedentes de hipotiroidismo gestacional no controlado migraña exposición topiramato en primer trimestre
Conductuales	
Ocupacionales	na
Ambientales	na
5. ANALISIS DEL CASO	

Análisis de causas:

Factores relacionados con el paciente: ¿Cuáles factores relacionados con las características y condiciones propias del paciente tales como su edad, su estado de consciencia, su capacidad de comunicarse, su grado de comprensión de las instrucciones considera usted que participaron en la ocurrencia del evento?

- RH o negativo de la madre con colocación de inmunoglobulina en semana 29
- Antecedentes maternos de exposición a topiramato , hipotiroidismo gestacional no controlado

Factores relacionados con la tarea y tecnología: Durante los procedimientos realizados al paciente, cuáles fueron las posibles deficiencias en la aplicación de las normas (protocolos y/o manuales) establecidos para la atención del paciente o fallas en la aplicación de barreras de seguridad como aplicación de correctos, listas de chequeo?

- Administración inadecuada de medicamento por parte de enfermería
- Administración de medicamento a un neonato no hospitalizado por el servicio de pediatría con historia clínica y orden medica formulada para la madre
- Inadecuada Indicación de la nota médica por parte de medicina general (no se evidencia nombre del medicamento , dosis y vía de administración del mismo)
- Falla en la farmacovigilancia institucional
- No aplicación de 10 correctos
- No están señalizados los medicamentos de alto riesgo para el servicio de ginecología

¿Con relación al evento, relacione los recursos para la toma de decisiones oportunas y pertinentes que no se encontraron disponibles para la atención, tales como imágenes diagnósticas, exámenes de laboratorio, personal especializado, etc.?

- Personal de salud rotatorio desde el grupo de enfermería sin experiencia en el servicio de ginecología
- Falla en proceso de Inducción del servicio de ginecología (personal de enfermería)

¿El análisis del caso se identifica posibles conductas o intervenciones sin indicación clara que pudieron facilitar o propiciar la aparición del evento? Relacione cuáles.

- Orden medica no clara de aplicación de medicamento (inmunoglobulina Anti D) sin tener claro el sujeto a quien se le debe administrar el medicamento , nombre del mismo , dosis y vía de administración.
- No están señalizados los medicamentos de alto riesgo
- Omisión de la doble verificación verbal y escrita de la orden de administración del medicamento

Factores relacionados con el personal responsable de la atención:
¿Consideran que durante el evento se presentaron fallas en el conocimiento, pericia o habilidades del personal en la ejecución de los procedimientos requeridos por el paciente? Relacione las actividades cuya ejecución pudo presentar deficiencias.

- Medico de turno realiza nota no clara con aplicación del medicamento
- Jefe de enfermería con desconocimiento de forma de administración del medicamento (tipo de medicamento – dosis – vía de administración)
- Múltiples punciones (4) al recién nacido con difícil acceso venoso

¿En el grupo que atendió al paciente se identifican alteraciones relacionadas con el estado de salud o fatiga que pudieron contribuir a la ocurrencia del evento?.

No

Ocupación en el turno
6 pacientes de urgencias
4 pacientes hospitalizadas

¿considera que se presentaron demoras en la atención del paciente, en su evaluación periódica, en la realización oportuna de los procedimientos requeridos y/o ausencias injustificadas del personal?

Después de la identificación del evento no se presentaron demoras en la evaluación del neonato y la monitorización estricta del mismo.

Demora en el análisis del evento de seguridad del paciente por parte del servicio de ginecología

No se reportó el evento de seguridad en ALMERA para el análisis

Factores relacionados con el equipo de trabajo:

¿Durante el proceso de atención relacionados con el evento, las instrucciones, órdenes médicas y/o de enfermería fueron adecuadamente transmitidas y comprendidas por todo personal o hubo elementos que alteraron el mensaje y ejecución? Mencione cuáles.

- Nota médica no clara en aplicación de inmunoglobulina anti-D a la paciente o al neonato (se coloca el nombre comercial en la orden , no se coloca dosis ni vía de administración del medicamento)
- Desconocimiento por parte de jefe enfermería de tipo de medicamento a administrar , y los 10 correctos en la administración del mismo
-

¿Existieron errores en la comunicación con el equipo de trabajo?

Si , falta de comunicación escrita y verbal en el equipo de trabajo

No se evidencia comunicación completa ni clara en la orden médica.

Factores relacionados con el ambiente: ¿Durante la atención del paciente hubo deficiencias en la disponibilidad y condiciones de funcionamiento de los equipos requeridos para atención del paciente, que pudieron tener injerencia en la ocurrencia del evento?

No

	Factores relacionados con Organización y cultura: ¿Durante los últimos 6 meses en el área de atención relacione cuáles procesos de capacitación y reentrenamiento del personal se han realizado en tareas relacionadas con los conocimientos y habilidades requeridas para prevenir el evento ocurrido? 12/08/2025 Revisión de protocolo de protocolo administración de medicamentos en el equipo primario de ginecología (soportes en ALMERA) **Otros aspectos relacionados:** Relacione a continuación otros factores contributivos que pudieron intervenir en el desarrollo del evento. ¿Existió Daño en el paciente?: si ¿Puedo haberse prevenido?: si

6. HALLAZGOS DEL ANALISIS

Modelo de demoras Deborah Maine

1. **Reconocimiento el problema: Si , posterior a la aplicación de la inmunoglobulina anti . D**
2. **Oportunidad de la decisión y de la acción: OPORTUNO posterior a la aplicación de la inmunoglobulina anti . D**
3. **Acceso a la atención/logística de referencia: ADECUADO**
4. **Calidad de la atención. xxxxx**

CONCLUSIÓN

Recién nacido de madre o negativo (con aplicación de inmunoglobulina anti D en semana 29 – descrito en historia clínica) con hemoclasificación Rh O+ a quien se le administra Inmunoglobuina anti D en las primeras horas de vida, se clasifica como un Evento adverso secundario a la atención en salud

7. DATOS DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL ANALISIS

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	**CÓDIGO:**
	FORMATO UNIDAD DE ANALISIS DE CASOS CLÍNICOS	SP-S-F-009
	PROCESO: GESTIÓN SEGURA	**VERSIÓN:**
	SUBPROCESO: SEGURIDAD DEL PACIENTE	V02-2026

Realizado por	Grupo ginecología- unidad de analisis HRM

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	CÓDIGO:
	FORMATO UNIDAD DE ANALISIS DE CASOS CLÍNICOS	SP-S-F-009
	PROCESO: GESTIÓN SEGURA	VERSIÓN:
	SUBPROCESO: SEGURIDAD DEL PACIENTE	V02-2026

HALLAZGO	CAUSA	ACCION DE MEJORA	CARGO Y RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	CARGO Y RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN
Administración del inmunoglobulina anti D al recién nacido	Nota medica no clara en indicación de la aplicación , sin dosis sin vía de administración con nombre comercial	• Notas de medicamentos de alto riesgo realizadas y formuladas por especialista • Verificación de medicamentos de alto riesgo por FARMACOVIGILANCIA	Servicio ginecología / Química Farmaceuta HRM	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	
Alta rotación servicio de ginecología	Jefe sin experiencia en ginecología en el servicio	Mejorar el proceso de inducción del personal en el servicio de ginecología	Coordinación enfermería	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	
No se realizaron los 10 correctos en la aplicación de medicamentos	No se realizaron los 10 correctos en aplicación de medicamentos	Capacitación al personal de enfermería y medicina sobre los 10 correctos. Medición de doble chequeo de medicamentos de alto riesgo	Lider enfermería ginecología	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	
Falla en la comunicación del equipo en el día del turno	No se realizó el doble chequeo de la información verbal y escrita con la aplicación del medicamento	Capacitación en Barreras de seguridad y verificación en las ordenes verbales y escritas	Servicio ginecología enfermería / medicina	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	
No se aplicó el Protocolo de prescripción correcta de medicamentos	Protocolo de prescripción correcta de medicamentos en elaboración	Socializar el Protocolo de prescripción correcta de medicamentos	Química Farmaceuta HRM	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	
Protocolo de isoinmunización por RH	Protocolo de isoinmunización por RH	Elaborar un Protocolo de isoinmunización por RH Ajuste de historia clínica fecha de aplicación de inmunoglobulina anti D y recomendaciones de isoinmunización	Servicio ginecología enfermería / medicina	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	
No se identifican los medicamentos de alto riesgo en ginecología	No se identifican los medicamentos de alto riesgo en ginecología	Elaboración de fichas de consulta rápida de identificación de medicamentos de alto riesgo en ginecología	Servicio ginecología enfermería / medicina	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	
Falla en la inducción del personal del servicio de ginecología	Falla en la inducción del personal del servicio de ginecología	Ajustar el protocolo de inducción en enfermería y medicina	Servicio ginecología enfermería / medicina	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	

Administración de medicamento a un neonato no hospitalizado por el servicio de pediatría con historia clínica y orden medica formulada para la madre	Administración de medicamento a un neonato no hospitalizado por el servicio de pediatría	Hospitalizar a todo recién nacido que requiera manejo con canalización, administración de medicamentos previamente por el servicio de pediatría	Servicio de pediatría	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	
Demora en el análisis del caso por parte del servicio de ginecología	Se evidencia demora en el análisis de evento de seguridad por parte del servicio de ginecología	Análisis inmediato del evento de seguridad del paciente con protocolo de Londres	Servicio ginecología enfermería / medicina	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	
Nota de egreso del neonato sin examen físico completo	Nota de egreso del neonato sin examen físico completo	Socializar protocolo egreso seguro y protocolo de historia clínica en el servicio de ginecología	Servicio ginecología enfermería / medicina	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	
Difícil canalización del recién nacido durante la estancia en ginecología	Difícil canalización del recién nacido durante la estancia en ginecología	Documentar y socializar protocolo de venopunción segura en paciente pediátrico	Servicio de pediatría	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	
Demora en diligenciamiento del RUAF por demora en reporte de hemoclasificación del recién nacido	Demora en diligenciamiento del RUAF por demora en reporte de hemoclasificación del recién nacido	Agilizar Tiempo de lectura de la hemoclasificación del recién nacido y el cargue en el sistema	Laboratorio clínico / subgerencia científica	Subgerencia científica. / seguridad del paciente	

8. ASISTENTES AL ANÁLISIS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.